ÁGORA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Espasticidad, rango articular y desempeño funcional en personas con secuelas de ACV

Autores: Grupo C | Docente: Luis Miguel Reina | Asignatura: Deficiencia Neuromuscular | Semestre: 5

Introducción

El accidente cerebrovascular (ACV) puede dejar secuelas motoras que afectan la movilidad y la independencia. Entre ellas, la espasticidad puede coexistir con debilidad, alteraciones del control motor y disminución del rango de movimiento articular (ROM). Estas alteraciones pueden dificultar actividades como caminar, realizar transferencias, vestirse y manipular objetos. Comprender cómo se relacionan con el desempeño funcional permite orientar una valoración fisioterapéutica integral y basada en la evidencia.

Planteamiento del problema

El ACV deja secuelas motoras como hemiparesia, espasticidad, pérdida de fuerza y control motor, y alteraciones del equilibrio y la marcha. Estas dificultan caminar, hacer transferencias, vestirse, alimentarse y manipular objetos, y pueden restringir la participación, la autonomía y la calidad de vida (Bavikatte et al., 2021; Bandela et al., 2026). Sin embargo, la espasticidad, el ROM y la función no se relacionan de forma única ni proporcional. Por ello, la pregunta del proyecto fue: ¿qué evidencia científica existe (2016–2026) sobre la relación entre estas variables en personas con secuelas de ACV?

Metodología

Revisión documental con enfoque de revisión de alcance y síntesis narrativa-descriptiva. Se consultaron PubMed/MEDLINE, Scopus, Cochrane Library, PEDro y SciELO;. Se combinaron términos en español e inglés sobre ACV, espasticidad, ROM y función mediante AND/OR.

Inclusión: adultos (>18 años) con secuelas de ACV; publicaciones 2016–2026, en español o inglés y texto completo; estudios observacionales, ensayos, revisiones y guías. Se extrajeron diseño, población, instrumentos, hallazgos y limitaciones en una matriz.

Resultados

De 22 registros identificados, se eliminaron 8 duplicados, se revisaron 14, se excluyeron 5 y se incluyeron 9 fuentes (2020–2026).

Obj. 1: 9 fuentes: 4 revisiones sistemáticas (2 con metaanálisis), 1 revisión paraguas, 1 revisión de alcance, 1 declaración científica y 2 estudios observacionales.

Obj. 2: solo 2 estudios primarios, Li et al. (2023; n=28) y Andersson et al. (2026; n=35), ambos en fase crónica, con instrumentos heterogéneos (Fugl-Meyer, TUG, acelerómetros).

Obj. 3: la espasticidad puede coexistir con restricción del ROM, pero el estiramiento no mostró beneficios consistentes. La asociación con la función varió según el segmento (sí en miembro superior, no en inferior). No hubo correlación cuantitativa directa ROM-función

Discusión

Los hallazgos indican que una mayor espasticidad no implica necesariamente menor funcionalidad. La relación cambia según la extremidad, la fase del ACV, los instrumentos y las características de cada persona. La movilidad articular puede verse afectada por factores neurales y musculoesqueléticos, mientras que las actividades cotidianas requieren además fuerza, equilibrio, coordinación y control motor. La heterogeneidad de diseños y medidas limita la comparación y no permite establecer causalidad.

Conclusión

La evidencia revisada muestra que espasticidad, ROM y desempeño funcional pueden relacionarse, pero no de forma directa ni proporcional. La valoración fisioterapéutica debe integrar tono muscular, movilidad activa y pasiva, fuerza, control motor y desempeño en tareas reales. Se necesitan estudios que midan conjuntamente las tres variables, con muestras mayores e instrumentos estandarizados, para precisar sus asociaciones y orientar intervenciones individualizadas.

Alt Murphy, M., et al. (2025). Eur Stroke J, 10(4), 1160–1188.
Andersson, S., et al. (2026). Front Stroke, 5, 1731911.
Bandela, S., et al. (2026). Stroke, 57(4), e146–e159.
Bavikatte, G., et al. (2021). J Cent Nerv Syst Dis, 13.

ODS 3